

## 论著·公共卫生

## 老年期痴呆伴发精神行为障碍的家庭医疗干预模式

杨道良<sup>1</sup>, 李霞<sup>2</sup>, 苏宁<sup>2</sup>, 季卫东<sup>1</sup>, 陈玄玄<sup>1</sup>

1. 上海市长宁区精神卫生中心, 上海交通大学 Bio-X 中心附属绿地医院精神科, 上海 200335; 2. 上海交通大学医学院附属精神卫生中心老年精神科, 上海 200030

**[摘要]** **目的**·探讨老年期痴呆伴发精神行为障碍的家庭医疗干预模式。**方法**·从上海市长宁区街道中整群抽取 4 个街道, 按照入组标准选取研究对象, 分为干预组 (71 例) 和对照组 (70 例)。针对干预组提供精神科医师上门服务, 给予药物治疗和心理社会干预。分别在基线时、6 个月末、12 个月末进行老年期痴呆患者病理行为量表 (BEHAVE-AD)、简易精神状态评定量表 (MMSE)、日常生活能力量表 (ADL)、老年期痴呆生活质量量表 (QOL-AD)、生活质量综合评定问卷 (GQOLI-74) 评分。**结果**·①对于干预前 2 组患者的 BEHAVE-AD 总分及各因子分进行比较, 差异无统计学意义 ( $P>0.05$ ); 重复测量方差分析显示, 评定时间主效应显著 ( $P<0.001$ ), BEHAVE-AD 总分、情感障碍和焦虑恐惧因子分主效应均存在显著差异 ( $P<0.001$ ), BEHAVE-AD 总分、妄想和情感障碍因子分主效应均存在显著差异 ( $P<0.05$ )。② BEHAVE-AD 评分组间比较: 在 6 个月末时, 就幻觉、昼夜节律紊乱、情感障碍和焦虑恐惧因子分而言, 干预组均明显优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P<0.01$ ); 在 12 个月末时, 就 BEHAVE-AD 总分及妄想、行为紊乱、情感障碍和焦虑恐惧因子分而言, 干预组均优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P<0.01$ )。③对于干预前 2 组患者的 MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分进行比较, 差异无统计学意义 ( $P>0.05$ ); 重复测量方差分析显示, 评定时间主效应显著 ( $P<0.001$ ), MMSE 和 QOL-AD 评分组别主效应均存在显著差异 ( $P<0.001$ ), MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分组别与时间交互作用均存在显著差异 ( $P<0.05$ )。④ MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分组间比较: 在 6 个月末时, 干预组 MMSE 评分优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P<0.05$ ); 在 12 个月末时, 就 MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分而言, 干预组均优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P<0.05$ )。**结论**·精神科医师上门服务并整合多学科团队的家庭医疗模式对改善老年期痴呆患者精神行为症状有效, 可以提高患者和照料者的生活质量, 持续开展效果更明显。

**[关键词]** 老年期痴呆; 精神行为障碍; 家庭医疗模式**[DOI]** 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.03.024 **[中图分类号]** R195 **[文献标志码]** A

## Family medical intervention model of senile dementia with behavioral and psychological symptoms

YANG Dao-liang<sup>1</sup>, LI Xia<sup>2</sup>, SU Ning<sup>2</sup>, JI Wei-dong<sup>1</sup>, CHEN Xuan-xuan<sup>1</sup>

1. Department of Psychiatry, Shanghai Changning District Mental Health Center, Green Land Hospital of Bio-X Center, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200335, China; 2. Department of Geriatric Psychiatry, Shanghai Mental Health Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200030, China

**[Abstract]** **Objective**·To explore family medical intervention model of senile dementia with behavioral and psychological symptoms. **Methods**·Four streets of Changning District in Shanghai were randomly selected and subjects were enrolled according to the inclusion criteria, who were randomly divided into the intervention group ( $n=71$ ) and control group ( $n=70$ ). The intervention group received door-to-door service from psychiatric doctors, given drug treatment and psychological intervention. Subjects were evaluated by several scales, including Behavioral Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale (BEHAVE-AD), Mini-Mental State of Examination (MMSE), Activity of Daily Living Scale (ADL), Quality of Life-Alzheimer's Disease (QOL-AD), and Generic Quality of Life Inventory-74 (GQOLI-74), at baseline and by the end of 6 months and 12 months. **Results**·① There was no significant difference in the total scores and all factor scores of BEHAVE-AD between the two groups before intervention ( $P>0.05$ ). Repeated measures analysis of variance revealed a significant main effect of time ( $P<0.001$ ). The between-group effect was significant in the total scores of BEHAVE-AD and the factor scores of affective disorder, anxiety and terror ( $P<0.001$ ). The interactive effect of time $\times$ group was significant in the total scores of BEHAVE-AD and the factor scores of delusion and affective disorder ( $P<0.05$ ). ② Inter-group comparison of the BEHAVE-AD scores indicated that by the end of 6 months, factor scores of hallucination, circadian rhythm disorder, affective disorder, anxiety and terror of the intervention group were remarkably better than those of the control group and the differences were statistically significant ( $P<0.01$ ). By the end of 12 months, total scores of BEHAVE-AD, and factor scores of delusion, conduct disorder, affective disorder, anxiety and terror of the intervention group were remarkably better than those of the control group and the differences were statistically significant ( $P<0.01$ ). ③ There was no significant difference in the scores of MMSE, ADL, QOL-AD and GQOLI-74 between the two groups before intervention ( $P>0.05$ ). Repeated measures analysis of variance revealed a significant main effect of time ( $P<0.001$ ). The between-group effect was significant in the scores of MMSE and QOL-AD ( $P<0.001$ ). The interactive effect of time $\times$ group was significant in the scores of MMSE, ADL, QOL-AD, and GQOLI-74 ( $P<0.05$ ). ④ Inter-group comparison of MMSE, ADL, QOL-AD, and GQOLI-74 scores indicated that by the end of 6 months, scores of MMSE of the intervention group were remarkably better than those of the control group and the differences were statistically significant ( $P<0.05$ ). By the end of 12 months, scores of MMSE, ADL, QOL-AD, and GQOLI-74 of the intervention group were remarkably better than those of the control group and the differences were statistically significant ( $P<0.05$ ). **Conclusion**·The family medical intervention model of door-to-door services from psychiatrists integrating multidisciplinary team is effective to attenuate the mental and behavioral symptoms of senile dementia patients, and can improve the quality of life of patients and caregivers. The effect of persistent implementation will be more remarkable.

**[Key words]** senile dementia; behavioral and psychological symptoms; family medical intervention model**[基金项目]** 上海市长宁区卫生和计划生育委员会科研课题 (20134Y06001) (Shanghai Changning District Health and Family Planning Commission Research Project, 20134Y06001)。**[作者简介]** 杨道良 (1981—), 男, 主治医师, 硕士; 电子信箱: ydlbbmc@sina.com。**[通信作者]** 陈玄玄, 电子信箱: chenxx2000@126.com。

随着人口老龄化进展, 痴呆的发病率和患病率正逐年提高, 中国正面临着急剧老龄化带来的老年人生活养老、医疗照料等一系列难以回避的现实问题。老年期痴呆较为常见的类型是阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 和血管性痴呆 (vascular dementia, VD), 在临床上以认知功能的全面减退为特征。随着研究的逐步深入, 其非认知症状也越来越引起研究者的关注。非认知症状包括抑郁、精神病性症状、行为紊乱、昼夜节律紊乱等, 国际老年精神病协会称之为痴呆的精神行为症状 (behavioral and psychological symptoms of dementia, BPSD)。Steinberg 等<sup>[1]</sup>对 61 例痴呆无 BPSD 的患者随访 18 个月后, 发现 69% 的患者出现了至少一种 BPSD。患者精神行为症状发作导致痴呆患者残疾程度加重, 患者的功能丧失比单纯由认知功能损害造成的更为严重, 也进一步对患者及周围人的人身安全构成威胁, 加重了家庭和社会的负担, 同时也是患者就医的主要原因。多数程度较轻的痴呆患者未能被人们所识别, 因而易被忽视。多数中重度痴呆患者合并 BPSD, 却缺乏有效的干预措施。本研究利用社区家庭医生签约的平台, 探索通过开展精神科医师上门服务整合多学科团队成员 (包括疾控精神卫生分中心工作人员、心理治疗师、康复治疗师、老年护理师等) 的家庭医疗模式服务于老年期痴呆伴发 BPSD 的患者, 现报告如下。

## 1 对象与方法

### 1.1 研究对象

采用整群抽样方法, 在长宁区 4 个街道收集痴呆伴 BPSD 的患者。入选标准: 符合国际疾病分类第 10 版 (ICD-10) 中 AD、VD 或混合性痴呆诊断标准的老年期痴呆患者; 患者有相对稳定的照料者; 以痴呆病理行为量表 (BEHAVE-AD) 评分  $\geq 8$  分评定是否有 BPSD。排除标准: 抑郁症所引起的假性痴呆患者; 谵妄患者; 其他神经系统疾病、系统性疾病和物质中毒所致的痴呆患者; 既往有精神疾病史 (如精神分裂症及情感性障碍) 的患者; 正处于心、血管、肺、肝、肾等重要器官疾病急性期的患者。选取其中 2 个街道的患者为对照组, 只给予药物治疗和一般的心理健康知识宣传 (即指通过各类媒体、各种方式开展的心理健康知识宣传, 如心理健康知识的宣传板报、宣传册、进社区的心理卫生知识讲座、心理健康义诊等)。选取另 2 个街道的患者为干预组, 提供精神科医师上门门诊服务, 经监护人知情同意, 给予药物治疗和心理社会干预。研究过程中因故 (疾病加重或住院、外出、死亡、搬迁、家庭重大生活事件等其他原因) 2 组均

有对象退出, 最终符合入组标准并完成研究全程者共 141 名。对照组 70 例, 其中男 32 例, 女 38 例, 平均年龄 ( $74.67 \pm 5.02$ ) 岁, 平均受教育年限 ( $10.99 \pm 3.76$ ) 年, 平均病程 ( $5.75 \pm 2.55$ ) 年; 干预组 71 例, 其中男 31 例, 女 40 例, 平均年龄 ( $76.11 \pm 6.30$ ) 岁, 平均受教育年限 ( $11.06 \pm 3.68$ ) 年, 平均病程 ( $5.44 \pm 2.42$ ) 年。

### 1.2 研究方法

**1.2.1 家庭医疗工作模式** 精神科医师上门服务同时整合多学科团队成员 (疾控精神卫生分中心工作人员、心理治疗师、康复治疗师、老年护理师等), 对照料者、社区家庭医生、社会工作者等进行痴呆卫生宣教, 利用社区的家庭医生制工作模式, 争取各居委会和社区卫生服务中心的支持, 同时对患者和照料者实施心理社会干预。

**1.2.2 心理社会干预内容** ①对痴呆照料者培训, 内容包括什么是痴呆及 BPSD, 其疾病进程的一般规律, 有效的治疗方法和时机, 护理要点、护理技巧和注意事项, 患者生活环境的布置, 同患者交流的技巧等, 以提高患者的服药依从性, 减少并发症, 并接受照料者的倾诉, 指导其放松, 加强心理支持和辅导。对患者灵活采用行为干预, 如日常生活能力训练、音乐疗法、怀旧和人生回顾、记忆训练等<sup>[2-3]</sup>, 并调整其居住环境的布置。②在患者急性期每周家访, 调整药物, 听取照料者及家属的意见, 提出合理建议。③待病情稳定后, 采取每周电话随访、每月上门随访方式, 针对存在严重疾病或行动不便者给予更关注, 适当增加探访频率以降低其风险概率。

**1.2.3 干预形式** ①对社区相关人员进行培训, 发放相关宣传材料 500 份。②建立老年痴呆家庭的自助互助小组, 互相分享讨论心得体会, 举办家庭成员活动。③开展每半年 1 次的相关人员座谈协调会, 讨论干预过程中遇到的问题及解决方案。

### 1.3 研究工具

**1.3.1 一般情况调查表** 用于了解痴呆患者以及照料者的一般情况, 包括性别、年龄、文化程度、病程、照料时间、与患者的关系等。

**1.3.2 简易精神状态评定量表 (Mini-Mental State of Examination, MMSE)** 用于评定痴呆患者的认知功能<sup>[4]</sup>。共计 19 项, 30 个小项, 计分范围为 0 ~ 30 分, 得分越高表示认知功能越好。

**1.3.3 老年期痴呆生活质量量表 (The Quality of Life-Alzheimer's Disease, QOL-AD)** 采用患者自评和照料者代评相结合的方式评定老年期痴呆患者的生活质量<sup>[5]</sup>, 共



有 13 道题目 (包括健康状况、精力、心情、生活状况、记忆力、家庭、婚姻、朋友、个人感觉、做家务的能力、做有趣事情的能力、经济情况和总体生活), 每题分为“差”“一般”“好”和“非常好”4 个选项, 分数范围为 13 ~ 52 分。

**1.3.4 日常生活能力量表 (Activity of Daily Living Scale, ADL)** 用于评定痴呆患者的日常生活能力。调查员按照表格内容逐项询问家属或照料者, 共计 14 项, 计分范围为 14 ~ 56 分。

**1.3.5 生活质量综合评定问卷 (Generic Quality of Life Inventory-74, GQOLI-74)** 用于评定照料者的生活质量<sup>[6]</sup>, 共 74 个题目, 为多维度评定, 包括躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活 4 个维度; 前 3 个维度各有 5 个因子, 物质生活维度有 4 个因子; 每个项目评分标准采用 5 级 (1 ~ 5 级), 评分越高, 该维度或总的生活质量越高。

**1.3.6 老年期痴呆患者病理行为量表 (Behavioral Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale, BEHAVE-AD)** 用于评定患者是否有 BPSD。它能比较全面且有效地评定痴呆患者的行为和精神症状, 已成为目前国际上常用的 BPSD 评定量表<sup>[7]</sup>。BEHAVE-AD 要求评定者根据照料者报告的患者近 2 周 BPSD 情况进行评分。共有 25 项条目, 包含 7 个分量表, 每项条目按症状严重程度分 4 级 (0 ~ 3 分) 评分。

## 1.4 评定方法

对所有患者随访 1 年, 调查 2 组患者干预前、干预 6 个月和 12 个月后各项指标的变化。

## 1.5 统计分析

使用 SPSS16.0 对数据进行分析, 定量资料比较采用  $t$  检验、多元方差分析和重复测量方差分析; 若球形检验 (Mauchly's Test of Sphericity) 显示  $P < 0.05$ , 则采用

Greenhouse-Geisser 对结果进行校正。定性资料比较采用  $\chi^2$  检验。以  $P < 0.05$  为差异有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 2 组间基本资料的比较

对干预组与对照组在性别构成比、年龄、受教育年限及病程方面进行比较, 差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ , 表 1)。

表 1 基本资料的组间比较 ( $\bar{x} \pm s$ )

Tab 1 Comparison of general data between two groups ( $\bar{x} \pm s$ )

| 项目         | 干预组              | 对照组              | $\chi^2/t$ 值 | P 值   |
|------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| 性别 / n (%) |                  |                  |              |       |
| 男          | 31 (43.7)        | 32 (45.7)        | 0.06         | 0.866 |
| 女          | 40 (56.3)        | 38 (54.3)        |              |       |
| 年龄 / 岁     | 76.11 $\pm$ 6.30 | 74.67 $\pm$ 5.02 | 1.50         | 0.136 |
| 受教育年限 / 年  | 11.06 $\pm$ 3.68 | 10.99 $\pm$ 3.76 | 0.11         | 0.910 |
| 病程 / 年     | 5.44 $\pm$ 2.40  | 5.75 $\pm$ 2.55  | -0.74        | 0.462 |

### 2.2 2 组干预前后 BEHAVE-AD 评分比较

对干预前 2 组患者 BEHAVE-AD 总分及各因子分进行比较, 差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ )。以评定时间为组内因素、组别为组间因素的重复测量方差分析显示, 评定时间主效应显著 ( $P < 0.001$ ), BEHAVE-AD 总分、情感障碍和焦虑恐惧因子分组别主效应均存在显著差异 ( $P < 0.001$ ), BEHAVE-AD 总分、妄想和情感障碍因子分组别与时间交互作用均存在显著差异 ( $P < 0.05$ )。组间比较结果显示, 在 6 个月末时, 就幻觉、昼夜节律紊乱、情感障碍和焦虑恐惧因子分而言, 干预组优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P < 0.01$ ); 在 12 个月末时, 就 BEHAVE-AD 总分及妄想、行为紊乱、情感障碍和焦虑恐惧因子分而言, 干预组优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P < 0.01$ ) (表 2、表 3)。

表 2 2 组的 BEHAVE-AD 各因子评分 ( $\bar{x} \pm s$ )

Tab 2 BEHAVE-AD scores of two groups ( $\bar{x} \pm s$ )

| BEHAVE-AD | 干预前              |                  | 干预后 6 月         |                 | 干预后 12 月        |                 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | 干预组              | 对照组              | 干预组             | 对照组             | 干预组             | 对照组             |
| 总分        | 14.19 $\pm$ 2.90 | 14.15 $\pm$ 2.77 | 7.76 $\pm$ 3.53 | 8.62 $\pm$ 3.94 | 5.87 $\pm$ 2.87 | 7.74 $\pm$ 3.56 |
| 妄想        | 3.33 $\pm$ 1.50  | 3.16 $\pm$ 1.20  | 1.72 $\pm$ 1.14 | 1.86 $\pm$ 1.31 | 0.51 $\pm$ 0.81 | 1.07 $\pm$ 1.05 |
| 幻觉        | 1.79 $\pm$ 1.07  | 1.83 $\pm$ 1.13  | 0.25 $\pm$ 0.44 | 0.49 $\pm$ 0.56 | 0.14 $\pm$ 0.35 | 0.17 $\pm$ 0.38 |
| 攻击行为      | 3.44 $\pm$ 1.40  | 3.26 $\pm$ 1.01  | 1.59 $\pm$ 1.04 | 1.73 $\pm$ 1.24 | 0.45 $\pm$ 0.71 | 0.99 $\pm$ 1.06 |
| 行为紊乱      | 3.51 $\pm$ 1.36  | 3.54 $\pm$ 0.99  | 1.63 $\pm$ 1.03 | 1.74 $\pm$ 1.14 | 0.31 $\pm$ 0.52 | 0.83 $\pm$ 0.90 |
| 昼夜节律紊乱    | 1.68 $\pm$ 1.04  | 1.71 $\pm$ 1.11  | 0.30 $\pm$ 0.46 | 0.66 $\pm$ 0.72 | 0.23 $\pm$ 0.57 | 0.26 $\pm$ 0.53 |
| 情感障碍      | 2.10 $\pm$ 1.07  | 2.16 $\pm$ 1.12  | 0.85 $\pm$ 0.58 | 1.44 $\pm$ 0.65 | 0.34 $\pm$ 0.48 | 0.66 $\pm$ 0.70 |
| 焦虑恐惧      | 1.10 $\pm$ 0.59  | 1.44 $\pm$ 0.65  | 0.28 $\pm$ 0.45 | 0.79 $\pm$ 0.68 | 0.14 $\pm$ 0.35 | 0.34 $\pm$ 0.48 |



表 3 BEHAVE-AD 各因子评分组间比较的统计值  
Tab 3 Statistical value for comparison of BEHAVE-AD scores between two groups

| BEHAVE-AD | $F_{\text{时间}}$ | $P$ 值 | $F_{\text{组别}}$ | $P$ 值 | $F_{\text{组别} \times \text{时间}}$ | $P$ 值 |
|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------------------------|-------|
| 总分        | 207.75          | 0.000 | 7.26            | 0.008 | 3.10                             | 0.047 |
| 妄想        | 166.31          | 0.000 | 2.03            | 0.157 | 3.70                             | 0.026 |
| 幻觉        | 223.21          | 0.000 | 1.88            | 0.172 | 0.90                             | 0.381 |
| 攻击行为      | 220.07          | 0.000 | 2.14            | 0.146 | 4.00                             | 0.019 |
| 行为紊乱      | 320.99          | 0.000 | 4.27            | 0.410 | 2.51                             | 0.086 |
| 昼夜节律紊乱    | 153.40          | 0.000 | 3.15            | 0.078 | 2.24                             | 0.118 |
| 情感障碍      | 150.18          | 0.000 | 16.91           | 0.000 | 4.05                             | 0.025 |
| 焦虑恐惧      | 135.82          | 0.000 | 41.94           | 0.000 | 2.76                             | 0.070 |

### 2.3 2 组干预前后 MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分比较

对 干 预 前 2 组 患 者 MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分进行比较, 差异无统计学意义 ( $P>0.05$ )。以评定时间为组内因素、组别为组间因素的重复测量方差分析显示, 评定时间主效应显著 ( $P<0.001$ ), MMSE 和 QOL-AD 评分组别主效应均存在显著差异

( $P<0.001$ ), MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分组别与时间交互作用均存在显著差异 ( $P<0.05$ )。组间比较结果显示, 在 6 个月末时, 干预组 MMSE 评分优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P<0.05$ ); 在 12 个月末时, 就 MMSE、ADL、QOL-AD、GQOLI-74 评分而言, 干预组优于对照组, 差异有统计学意义 ( $P<0.05$ ) (表 4、表 5)。

表 4 2 组的 MMSE、ADL、QOL-AD 和 GQOLI-74 评分 ( $\bar{x} \pm s$ )  
Tab 4 MMSE, ADL, QOL-AD, and GQOLI-74 scores of two groups ( $\bar{x} \pm s$ )

| 量表       | 干预前                |                    | 干预后 6 月            |                    | 干预后 12 月           |                    |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | 干预组                | 对照组                | 干预组                | 对照组                | 干预组                | 对照组                |
| MMSE     | 9.88 $\pm$ 2.33    | 9.85 $\pm$ 1.89    | 12.31 $\pm$ 2.43   | 11.32 $\pm$ 3.21   | 14.97 $\pm$ 3.03   | 13.27 $\pm$ 3.02   |
| ADL      | 38.56 $\pm$ 8.35   | 37.21 $\pm$ 5.93   | 33.92 $\pm$ 8.04   | 34.69 $\pm$ 6.11   | 30.85 $\pm$ 11.14  | 34.09 $\pm$ 6.17   |
| QOL-AD   | 33.17 $\pm$ 8.85   | 33.09 $\pm$ 6.05   | 35.39 $\pm$ 7.90   | 33.40 $\pm$ 6.02   | 39.13 $\pm$ 8.08   | 34.49 $\pm$ 6.96   |
| GQOLI-74 | 206.73 $\pm$ 34.75 | 206.64 $\pm$ 33.79 | 216.61 $\pm$ 36.10 | 210.84 $\pm$ 30.58 | 236.87 $\pm$ 42.99 | 219.51 $\pm$ 39.32 |

表 5 MMSE、ADL、QOL-AD 和 GQOLI-74 评分组间比较的统计值  
Tab 5 Statistical value for comparison of MMSE, ADL, QOL-AD, and GQOLI-74 scores between two groups

| 量表       | $F_{\text{时间}}$ | $P$ 值 | $F_{\text{组别}}$ | $P$ 值 | $F_{\text{组别} \times \text{时间}}$ | $P$ 值 |
|----------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------------------------|-------|
| MMSE     | 95.15           | 0.000 | 10.54           | 0.001 | 3.71                             | 0.026 |
| ADL      | 22.24           | 0.000 | 0.94            | 0.330 | 3.86                             | 0.022 |
| QOL-AD   | 10.04           | 0.000 | 8.05            | 0.005 | 3.77                             | 0.024 |
| GQOLI-74 | 25.39           | 0.000 | 2.37            | 0.126 | 4.14                             | 0.019 |

## 3 讨论

我国人口老龄化和高龄化日趋明显。流行病学研究显示, 痴呆主要在老年期发病, 它影响了大约 5% 的 65 岁以上的老年人, 和几乎一半的 85 岁以上的老年人<sup>[8]</sup>。BPSD 在痴呆患者中有较高的发病率, 50% ~ 90% 的痴呆患者伴有 BPSD, 其中 30% ~ 50% 的患者伴有幻觉, 30% ~ 80% 的患者伴有妄想, 30% ~ 40% 的患者伴有抑

郁, 30% ~ 70% 的患者伴有行为异常<sup>[9]</sup>。Lyketsos 等<sup>[10]</sup>报道美国 Cache 郡 329 例痴呆患者中, 201 例 (61%) 在过去一月中有至少一种 BPSD。BPSD 可导致家庭照料者生活质量下降, 照料负担增加, 照料者体力消耗和精神压力增大。痴呆患者多以家庭照料为主, 良好的家庭干预策略可以有效减少患者 BPSD 的出现, 延缓疾病进展, 提高患者生活质量, 减少家庭照料负担。为此, 本研究尝试采取精神科医师上门服务整合多学科团队成员的家庭医疗模

式来处理痴呆患者的 BPSD。

通过对干预前后 BEHAVE-AD 总分和各因子分的比较分析发现, 干预组和对照组均可缓解痴呆患者的 BPSD, 干预组对幻觉和昼夜节律紊乱的近期效果优于对照组, 对 BEHAVE-AD 总分、妄想和行为紊乱的远期效果优于对照组, 对情感障碍和焦虑恐惧的近远期效果都优于对照组。干预组除了常规药物干预外, 还采用了音乐治疗、日常生活能力训练等心理社会干预。这样不仅从生物学途径给予患者影响, 而且还通过纠正患者的不良行为习惯, 促使其参加娱乐活动和生活实践活动, 消除患者对周围环境的怀疑和恐惧心理, 增加与社会的接触, 增强自信心, 从而减轻患者的 BPSD, 并有助于降低 BPSD 复发的可能性。

本研究显示, 在 6 个月末时, 干预组 MMSE 评分优于对照组, 差异有统计学意义。在 12 个月末时, 干预组 MMSE、ADL、QOL-AD 和 GQOLI-74 评分均优于对照组, 差异有统计学意义。这些结果表明心理社会干预模式近期可改善认知功能, 远期具有明显的改善患者认知功能、日常生活能力、生活质量和照料者生活质量的效果, 且具有一定的持续性, 从而能够减轻家庭负担, 节省医疗成本, 也有助于 BPSD 的改善和预防, 这与此前一些研究

结论一致<sup>[11]</sup>。有报道<sup>[12]</sup>称对老年痴呆患者进行科学规律的社区康复干预能够明显改善患者的一般病理状况, 提高患者的生活质量和适应社会的能力。Baines<sup>[13]</sup>和 Head<sup>[14]</sup>分别采用怀旧和人生回顾进行相关研究, 结果显示: 患者综合认知功能得以维持, 并有提高趋势。由于痴呆患者病情呈进行性改变, 对于照料者的依赖会不断增加, 这种依赖的增加易导致痴呆照料者的心理压力增加, 使其生活质量下降; 而照料者生活质量下降对于痴呆患者康复有明显负面影响。本研究通过心理社会干预, 使照料者认识和了解痴呆的相关知识, 对存在的问题有针对性地进行科学的调整, 传授各种技巧, 建立家庭互助小组, 使得他们能互相帮助、互相对照、互相激励, 产生团队的合力, 通过心理咨询和治疗, 能达到倾听、解释、认知纠正、放松训练等目的。

本研究也存在不足之处, 如样本数不够大, 对经济负担、治疗费用等方面未涉及, 有待今后进一步探索。

综上所述, 精神科医师上门服务整合多学科团队成员的家庭医疗模式对改善老年期痴呆患者的 BPSD、认知功能具有较好的近期和远期效果, 有助于提高患者及照料者的生活质量, 减少疾病负担, 延缓疾病进展, 延迟患者进入养老机构的时间, 达到良好的社会效益。

## 参 · 考 · 文 · 献

- [1] Steinberg M, Sheppard JM, Tschanz JT, et al. The incidence of mental and behavioral disturbances in dementia: the cache county study[J]. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 2003, 15(3): 340-345.
- [2] Kasl-Godley J, Gatz M. Psychosocial interventions for individuals with dementia: an integration of theory, therapy, and a clinical understanding of dementia[J]. Clin Psychol Rev, 2000, 20(6): 755-782.
- [3] 黄晓峰, 谢道俊, 张娟, 等. 痴呆精神行为症状临床研究进展 [J]. 中医药临床杂志, 2015, 27(10): 1483-1485.
- [4] 于相芬, 孙振晓, 孙波, 等. 阿尔茨海默病与血管性痴呆患者精神行为症状的对照研究 [J]. 四川精神卫生, 2015, 28(3): 197-199.
- [5] 胡号应, 苗国栋, 唐牟尼, 等. 不同社区照管模式对痴呆患者生活质量的效果 [C] // 中国心理卫生协会老年心理卫生专业委员会. 第八届学术年会论文汇编, 2006.
- [6] 张作记. 行为医学量表手册 [J]. 中国行为医学科学, 2001, 12(增刊): 19-25, 74-81.
- [7] 盛建华, 陈美娟, 高之旭, 等. 阿尔茨海默病病理行为评分表信度和效度 [J]. 临床精神医学杂志, 2001, 11(2): 75-77.
- [8] 邢秋泓, 解恒革. 痴呆的精神行为症状及其药物治疗 [J]. 临床药物治疗杂志, 2012, 10(2): 31-35.
- [9] Xiao SF. Treating the behavioral and psychological symptoms of senile dementia with antipsychotic drugs[J]. Shanghai Arch Psychiatry, 2011, 23(6): 376-377.
- [10] Lyketsos CG, Steinberg M, Tschanz JT, et al. Mental and behavioral disturbances in dementia: findings from the Cache County Study on Memory in Aging[J]. Am J Psychiatry, 2000, 157( 5): 708-714.
- [11] 黄国明, 黄河浪, 钊雪林, 等. 阿尔茨海默病精神行为异常的综合干预研究 [J]. 江西医学院学报, 2005, 45(6): 65-67.
- [12] 肖闻宇, 郑舒华, 何小珍. 社区护理干预对老年期痴呆患者及照料者生活质量影响的研究 [J]. 中华全科医学, 2016, 14(1): 150-152.
- [13] Baines S, Saxby P, Ehler K. Reality orientation and reminiscence therapy. A controlled cross-over study of elderly confused people[J]. Br J Psychiatry, 1987, 151: 222-231.
- [14] Head DM, Portnoy S, Woods RT. The impact of reminiscence groups in two different settings[J]. Int J Geriatr Psychiatry, 1990, 5(5): 295-302.

[收稿日期] 2016-11-21

[本文编辑] 邵碧云

